

NO.	INDIKATOR KERJA	SASARAN	KENDALA	CATATAN	REKOMENDASI
1	Coding	Kepatuhan dokter	Pengisian anamnesa pasien belum lengkap, contoh : (kontrol lambung)	berkoordinasi dg DPJP utk penyesuaian anamnesa pemeriksaan fisik dan diagnose oleh asisten poli (dipantau oleh casemix)	1. Melengkapi anamnesa sesuai dengan keluhan pasien, contoh : (kontrol lambung, nyeri perut, nyeri ulu hati) 2. Menambah PC di meja periksa depan poli 3. Dibuat P-1 untuk melakukan pemeriksaan dan entri data TTV dan anamnesa, sehingga petugas tidak keluar masuk untuk entri data 4. Setiap anamnesa yg hanya bertuliskan kontrol atau keluhan yg tidak sesuai dengan diagnose , maka asisten berkewajiban untuk mengkonfirmasi kembali ke dpjp utk penyesuaian diagnose sesuai dg riwayat diagnose sebelumnya.

2	Verifikasi RJ	Kelengkapan berkas klaim on the trek	1. Masih menemukan bbrp berkas penunjang yg blm terlampir (EKG blm di scan dari IGD) 2. Ada yg masih buka billing (tambahan usg abd, fnab), tambahan obat 3. Masih menerima tgl yg lampau kebanyakan kontrol post mrs (post mrs, menunggu koding rawat inap yg belum diverif) 4. Masih menemukan beberapa yg belum diupload untuk SRK dan SEP nya 5. Jika konsultasi internal antar poli (dalam 1 hari) untuk billing dan kodingnya bagaimana? Apakah ditulis semua koding antar poli tsb? 6. Memungkinkah jika billing (kwitansi) rajal dan ranap BP JS ketenagakerjaan ndak	1. Revisi SPO skrining EKG & Thorax, DL, GDA Creatinin, di sesuaikan dg kondisi (spo saat ini usia 40 th ke atas wajib Thorax & EKG) Koodinasi dengan dr Arief Sp.M jika px Tindakan op mata resep control pertama dibuat di awal saat pasien kunjungan operasi, kemudian pengobatan untuk control berikutnya dijadikan satu paket Tambahan pemeriksaan dan terapi diluar jam praktek dpjp maka dijadwalkan saat control berikutnya atau edukasi pasien utk control umum pro pemeriksaan dan terapi tambahan. 2. Bekas px RI sdh lengkap dg codingnya Ketika px KRS 3. Saling mengingatkan apabila berkas belum lengkap krn berefek gagal klaim	1. Mereview SPO skrining pemeriksaan penunjang sesuai dg indikasi medis saja. Hasil bacaan ekg di rajal igd dibuat dan di ttd oleh dokter yang bertugas. Hasil bacaan ekg pasien ranap dan rajal poli spesialis dibuat dan di ttd oleh dokter dpjp 2. Updating PPK dan CP px catarac beserta control pertama post operasi utk menjadikan satu episode atau terpisah dg rentang wkt > 7 hr, system pembagian urgus entri di SIM RS Khanza 3. Diadakan rapat antar DPJP (Komdik) dan casemix (TKMKB) utk menyamakan persepsi shg resume medis dan coding bs terpenuhi ketika px KRS dan bagian pendaftaran menyiapkan berkas control dg kitiran poli`
---	---------------	--------------------------------------	--	---	--

			dikerjakan 2x? Karena pihak bpjstk mengacu dengan tarif yg dipks bukan tarif rs	4. Menggunakan DU sesuai poliklinik perujuk (koding yg paling prioritas). 5. Tarif sdh diputuskan oleh RS utk disamakan semua penjaminan. 6.	4. Diagnosis dan koding di kembalikan kepada kewenangan DPJP 5. Re-sosialisasi SPO yg berlaku oleh FO, Instalasi Rawat jalan, IGD farmasi dan Kasir 6. Security diharapkan membantu membagi alur registrasi pasien dan mengaktifkan Kembali APM di lobby RS 7. Solialisasi di unit rajal 8. Sosialisasi ulang kepada DPJP tentang proses ERM di khanza yang ter update 9. Mhn utk pembahasan ulang di tim tarif RS utk pembuatan paket-paket non BPJS
3	Jasaraharja	Prosedur pembiayaan pasien JR	1. Perubahan kronologi kejadian menyesuaikan dari kepolisian (jika laka Tunggal atau tabrak lari dengan RJ/Rujuk) karena penjamin BPJS bukan JR 2. Adanya kronologi yg tidak sama dengan kejadian dari pihak perusahaan (BPJS TK)	1. Menjadi px umum menunggu LP Jika px tdk mampu bayar maka TTD penundaan pelayanan dahulu 2. KIE dan Inform consent pembiayaan dan toleransi waktu kepada pasien dan keluarga untuk memastikan pelayanan tetap di	1. Pembuatan SPO oleh unit terkait dan disosialisasikan ke unit terkait 2. Pembuatan SPO oleh unit terkait dan disosialisasikan ke unit terkait

			3. Kendala terbitanya no LP kepolisan sertiap ada acara operasi lalu lintas besar 4. Setiap pasien dengan diagnosa COR apakah bisa di sarankan untuk di lakukan ct scan karena itu bisa menambah costing di rs.selama ini klaim JR rawat inap rata" di diagnosa COR di bawah 10 jt sedangkan total maks 20 jt	utamakan dg bermaterai. 3. KIE dan Inform consent pembiayaan dan toleransi waktu kepada pasien dan keluarga untuk memastikan pelayanan tetap di utamakan dg bermaterai. 4. Dibuatkan paket dengan penunjang ct scn kepala (buatkan table Riwayat pembiayaan dg ct dan tidak, serta melakukan update costing JR setiap hari.	3. Pembuatan SPO oleh unit terkait dan disosialisasikan ke unit terkait 4. Masih didiskusikan dalam TKMKB
--	--	--	---	--	---

NO.	INDIKATOR KERJA	SASARAN	KENDALA	CATATAN	REKOMENDASI
4	Penunjang medis	1. Radiologi 2. Laboratorium	1. Hasil foto antara SP.Rad dan DPJP tidak sama 2. Lamanya keluar hasil PA bervariasi sehingga menghambat klaim	1. Adanya permintaan DPJP untuk mengganti hasil bacaan yang tidak sesuai dengan bacaan Sp.Rad 2. Hasil pemeriksaan PA tidak berseragam (terlalu lama) sehingga belum bisa klaim	1. Kebijakan tentang hal tersebut 2. Dibuatkan prosedur yang jelas tentang hasil PA
5	Efisiensi penggunaan Obat	1. Farmasi	1. Penggunaan obat paten yang mahal	1. Pemberian obat px JKN : pemanfaatan obat generic belum maksimal (farmasi mengeluh kesulitan mencari principle nya) 2. Dpjp masih memberikan obat paten ke pasien bpjs 3. Pemberian obat px JR : pemanfaatan obat generic dengan JR care 4. Pemberian obat px TK disesuaikan dengan plafon BPJS TK	1. Pembutan CP sesuai penjamin biaya dengan mengacu pada plafon masing – masing penjamin 2. Harga yang tinggi pada pasien bpjs sehingga platform habis di obat 3. Menetapkan untuk semua pasien bpjs menggunakan generic atau obat paten penyesuaian harga 4. Menambah jumlah principle obat generic 5. Dibatasi paket TK / JR untuk membatasi kelebihan costing

6	Obat kronis	Farmasi	Strategi pemanfaatan dan penggunaan obat kronis yg harus dipatuhi ketepatan waktu control dengan waktu obat habis, serta dilengkapi dengan pemeriksaan penunjang	1. Jadwal praktik Ganti sebelum H – 7 karena aplikasi H-Fiz sudah di lock. 2. System pemberian obat kronis di tetapkan dalam Apotik online BPJS (perlu bridging dg Apol tetapi butuh penyesuaian di internal RS dahulu) 3. Diperlukan kerja 2 kali untuk verifikasi dan validasi resep untuk menentukan layak klaim, menambah beban kerja farmasi 4. Kepatuhan DPJP untuk penerapan restriksi obat kronis masih belum maksimal	1. Penertiban jadwal praktik dokter 2. Informasi restriksi obat kronis 3. Mengurangi polifarmasi 4. Membuat notifikasi obat kronis dalam RM pasien dg color code (blue) dan memberikan catatan waktu/jadwal pemeriksaan berkala.
7	Pelayanan Medis	1. DPJP	1. Visite DPJP	1. DPJP tidak melakukan Visite setiap hari sehingga: a. resume medis sering belum lengkap Ketika px KRS b. DPJP ijin tdk masuk 2. Komunikasi terapeutik antar DPJP kurang maksimal 3. Utk visite harian DPJP msh mendelegasikan ke dokter umum utk menggantikannya	1. Pembuatan prosedur tentang DPJP yg sesuai dg regulasi bahwa pengganti DPJP harus sama kompetensinya. 2. Pembuatan prosedur ijin cuti dpjp minimal H-7 sebelum cuti untuk pendelegasian tanggung jawab ke dpjp yang sama kompetensinya (difasilitasi oleh RS)